

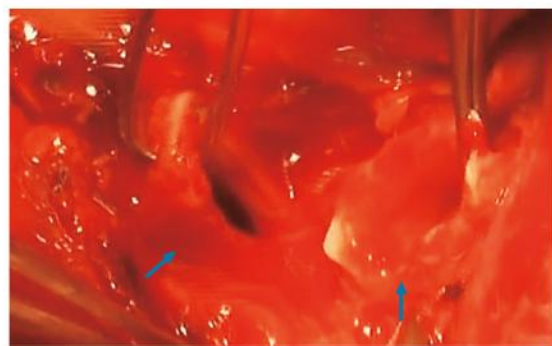


a.



気管支離断

b.

主気管支  
(中枢側)主気管支  
(末梢側)

c.

図2 ドレナージでも肺拡張が得られない気胸

著しい縦隔気腫と皮下気腫を認める。

a: 肺内は斑状、網状陰影。右肺は肺門より離れて虚脱。

b, c: 気管支離断のCTおよび術中所見。

なことも報告されている<sup>4)</sup>。

#### e 心電図

鈍的な心損傷で伝導ブロック、ST変化、Q波、QT延長、不整脈がみられ心電図のモニタリングは大切である。心タンポナーデでは頸静脈怒張や心音減弱にECG低電位がみられる。

### 治療

胸部外傷の多くの場合、多発外傷を伴っており、胸部も含めて生命の危険をもたらす箇所の優先順位を決める必要がある。病態を見極めて的確で迅速な処置や治療法を選択することが大切である。

#### a 薬物、輸液、輸血

疼痛コントロールの鎮痛薬、鎮静薬、感染防止の抗菌薬、肺傷害に伴う急性呼吸窮迫症候群 (acute respiratory distress syndrome: ARDS) に対して好中球エラスターゼ阻害薬、副腎皮質ステロイド薬投与が行われる。出血が多く血管内容量の減少に伴う循環動態が不安定な場合は、輸液や輸血を行う。アシドーシスには、補正が必要である。

#### b ドレナージ

気胸や血胸などを伴う場合に行われる。緊急で挿入するチェストチューブの場合は、適切な位置に留置することに注意を払う必要がある<sup>5)</sup>。トロッカー付ドレーンチューブは肺動脈や心臓損傷、癒着箇所の肺を損傷する可能性もあるので、用手指で肋間を十分開いて誘導しながらチューブを挿入する。刺入部は第4か第5肋間の中または前腋窩線上を選ぶ。第6肋間以下は横隔膜損傷の危険があり避けるべきである。貯留血液が多い心タンポナーデに対してはエコー診断装置を用いた心臓穿刺での吸引排液を行う。この際は、心筋損傷に注意が必要であり熟練者により施行されるべきである。気道損傷や肺挫傷に対する血液吸引や、無気肺に対する気道内分泌物吸引は気管支鏡が有用である。

#### c 胸壁固定

軽度の肋骨の骨折には胸帯 (バストバンド) による固定を行う。動揺胸郭が認められ呼吸が不安定な場合は、疼痛管理と胸壁固定のための陽圧人工呼吸管理 (内固定) の適応である。また外科的なプレートによる外固定術を行うことにより人工呼吸管理を短縮できるので、著しい胸壁の偏位には検討される。